

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 1 de 7

1. Executantes

1.1 Profissional da saúde treinado.

2. Resultados Esperados

- 2.1 Padronizar a conduta relacionada à coleta de sangue venoso em ambiente domiciliar para análise laboratorial;
- 2.2 Orientar os colaboradores do setor como coletar sangue venoso com eficiência e segurança para realização dos exames;
- 2.3 Obter amostras de sangue venoso em quantidade necessária, nos tubos corretos, para a realização dos exames prescritos, de forma segura e eficiente, garantindo a integridade das amostras e dos pacientes.

3. Materiais Necessários

3.1 Amostras

3.1.1 Sangue total coletado em tubos com aditivos como EDTA, citrato de sódio, tubo com gel separador ou tubo seco;

3.2 Materiais e Equipamentos

- 3.2.1 Agulha ou scalpe com dispositivo a vácuo (calibre 21G, 22G e 23G);
- 3.2.2 Garrote;
- 3.2.3 Espasmodrupo / micropore / curativo;
- 3.2.4 Algodão ou gaze;
- 3.2.5 Seringas (3mL, 5mL e 10mL);
- 3.2.6 Tubos de coleta (EDTA, citrato de sódio, tubo seco e com gel separador);
- 3.2.7 Recipiente rígido para descarte de perfurocortantes (Grupo E do PGRSS – materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como agulhas e lâminas de vidro, contaminados ou não);
- 3.2.8 Grade para os tubos;
- 3.2.9 Etiquetas dos tubos;
- 3.2.10 Álcool 70%;
- 3.2.11 EPI's: Jaleco e luvas de procedimento;

3.3 Reagentes

3.3.1 Não aplicável.

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 2 de 7

4. Descrição das Atividades

4.1 Procedimentos para agendamento de coleta domiciliar:

4.1.1 Em caso de solicitação de coleta domiciliar, a Unidade Solicitante deverá encaminhar a guia de requisição de exames do Olostech (com agendamento ou pré agendado) ao Posto de Coleta pessoalmente, via e-mail ou WhatsApp. Esse procedimento poderá variar de acordo com o Posto de Coleta;

4.1.2 Importante confirmar os dados na guia de requisição de exames, como: Nome completo do paciente, matrícula no Olostech, endereço, telefone de contato, e se a guia está carimbada e assinada pelo requisitante;

4.1.3 Após o recebimento da guia, o colaborador do Posto de Coleta entrará em contato por telefone com a família do paciente combinando o dia e horário da coleta. Importante ressaltar que a data de agendamento constante na guia da requisição de exames não garante coleta no mesmo dia do agendamento, uma vez que o Posto de Coleta depende de transporte e de transferência de local de coleta, quando esse não sair como prestador do serviço;

4.1.4 Em seguida, a Unidade Solicitante deverá encaminhar via e-mail para olos.laboratorios@gmail.com, com até 5 dias úteis de antecedência, a lista de pacientes que necessitam de agendamento de coletas domiciliares, com a data que será realizada a coleta pela equipe do Posto de Coleta. Esse procedimento se faz necessário para que o LMJ agende esses pacientes na agenda específica para coleta domiciliar;

4.1.5 Importante: Caso seja a própria Unidade Solicitante a responsável pela coleta, a mesma necessita comunicar previamente em tempo ábil o agendamento dessa coleta para que o Posto de Coleta se organize com a separação dos materiais necessários e para o recebimento/envio dessas amostras ao LMJ;

4.2 Procedimentos preparatórios anteriores à coleta domiciliar:

4.2.1 Após o agendamento da coleta domiciliar, se faz necessário o cadastro da guia de requisição de exames do Olostech no Sistema MV Soul e a emissão das etiquetas;

4.2.2 O Posto de Coleta irá realizar esse procedimento de acordo com sua rotina e demanda, e após a emissão do protocolo de atendimento e das etiquetas, separará os tubos e materiais necessários para a coleta, como agulhas, seringas, algodão, álcool 70%, garrote, curativo, descarpac, maleta e grade para transporte de amostras biológicas, entre outros;

4.3 Momento da coleta domiciliar:

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 3 de 7

- 4.3.1 Conferir documento do paciente junto ao protocolo de cadastro, checando o nome e data de nascimento do paciente;
- 4.3.2 Verificar as etiquetas se conferem com o protocolo e guia do Olostech. Em caso de alguma divergência, escrever na guia a alteração e devolver a guia ao colaborador responsável pelo cadastro, que providenciará a correção dos dados;
- 4.3.3 Perguntar ao paciente ou familiar sobre as medicações que toma, e se tem algo a mais pra complementar (episódio anterior de AVC, veias de difícil coleta, quimioterapia, etc.);
- 4.3.4 Solicitar ao paciente ou familiar que informem sua data de nascimento e nome completo e conferir com o protocolo de retirada;
- 4.3.5 Separar os tubos que serão necessários para os exames requisitados e deixá-los na ordem correta de coleta (ver Figura 1);
- 4.3.6 Fazer a higienização simples ou alcoólica das mãos e calçar as luvas;
- 4.3.7 Informar ao paciente ou familiar como será o procedimento e orientá-lo a posicionar o braço levemente inclinado para baixo, a partir da altura do ombro, tornando as veias acessíveis;
- 4.3.8 Abrir o lacre da agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, ou os invólucros da seringa e agulha, em frente ao paciente. Rosquear a agulha no adaptador do sistema a vácuo, ou na seringa se a coleta for feita no sistema aberto;
- 4.3.9 Garrotear o braço do paciente cerca de 4 cm acima do local da punção. Jamais dar “tapinhas” no local escolhido para a punção. Se necessário, pedir ao paciente que feche a mão;
- 4.3.10 Escolher o local da punção evitando áreas com hematomas, cicatrizes (queimaduras, cateterismo), mastectomia, fístulas ou recebendo terapia intravenosa;
- 4.3.11 Proceder a antisepsia no braço do paciente com algodão embebido em álcool 70% ou álcool-swab. Limpar o local com um movimento circular do centro para fora. Aguardar a secagem da área por 30 segundos para prevenir hemólise da amostra e reduzir a sensação de ardência na venopunção. **Atenção:** Não assoprar, não abanar e não colocar nada no local. Não tocar novamente na região após a antisepsia;
- 4.3.12 O procedimento de punção poderá ser realizado com seringa e agulha ou a vácuo, conforme detalhado a seguir:

*** COLETA À VÁCUO:**

- 4.3.13 Retirar a proteção que recobre a agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo;

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 4 de 7

4.3.14 Realizar a punção com o bisel da agulha voltado para cima, perfurando a veia com a agulha em ângulo de 30° ou menos;

4.3.15 Inserir o primeiro tubo a vácuo. Quando o sangue começar a fluir para dentro do tubo, afrouxar o garrote e pedir para que o paciente abra a mão;

4.3.16 Realizar a troca dos tubos à medida que atingem o volume preconizado, atentando-se à sequência correta de coleta dos tubos. Proceder a inversão de forma suave de 8 a 10 vezes, conforme figura 1. Remover a agulha, ativar o sistema de segurança da agulha e descartar em recipiente para materiais perfurocortantes. Fazer a compressão no local da punção, com algodão ou gaze secos. Observação: Se o adaptador de sistema a vácuo for de uso único, este deve ser desprezado junto com a agulha.

*** COLETA COM SERINGA:**

4.3.17 Verificar se a agulha e a seringa estão bem adaptadas para evitar a formação de espuma. Retirar a proteção da agulha hipodérmica;

4.3.18 O bisel da agulha deve estar voltado para cima, perfurando a veia com a agulha em ângulo de 30° ou menos;

4.3.19 Afrouxar o garrote do braço do paciente assim que o sangue começar a fluir dentro da seringa;

4.3.20 Puxar o êmbolo delicadamente, aspirando devagar o volume necessário, de acordo com a quantidade de sangue requerida para os tubos a serem utilizados;

4.3.21 Remover a agulha do braço do paciente e fazer a compressão no local da punção, com algodão ou gaze secos. Retirar a agulha da seringa e transferir o sangue para o tubo de coleta, tomando o cuidado para não encostar a seringa nos anticoagulantes, deslizando o sangue na parede do tubo de forma CUIDADOSA. Respeitar ao máximo a exigência da proporção sangue/aditivo e proceder a inversão de forma suave de 8 a 10 vezes. A sequência de utilização dos tubos deve ser conforme Figura 1.

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 5 de 7

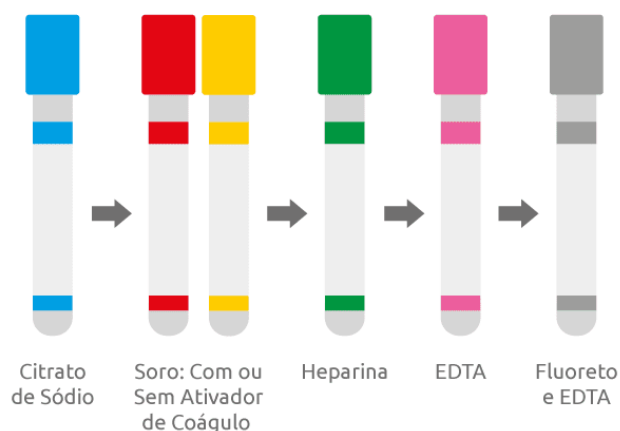


Figura 1: Sequência recomendada para utilização dos tubos de coleta.

4.3.22 Tanto para a coleta a vácuo, como para a coleta com agulha e seringa, após o procedimento, deve-se exercer pressão no local, em geral, de 1 a 2 minutos, evitando-se, assim, a formação de hematomas e sangramentos. Orientar o paciente para que realize este processo;

4.3.23 Colar as etiquetas de identificação das amostras com o código de barras na posição VERTICAL com o número de pedido do paciente para cima sobre a etiqueta do fabricante do tubo de forma a marcação do volume especificado, conforme Figura 2:



Figura 2: Padrão de identificação dos tubos de amostras sanguíneas.

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 6 de 7

4.3.24 Etiquetar as amostras na frente do paciente ou familiar e mostrar para o mesmo todos os tubos para confirmação do seu próprio nome, sendo o coletador responsável pela leitura do nome completo em voz alta;

4.3.25 Colocar o micropore no local da punção. Orientar o paciente a não dobrar o braço, não carregar peso ou bolsa a tiracolo no mesmo lado da punção por, no mínimo, 1 hora, e não manter a manga dobrada, pois pode funcionar como torniquete.

4.4 Finalização do procedimento no Posto de Coleta:

4.4.1 Após finalizar todas as coletas e retornar ao Posto de Coleta, o colaborador deverá levar todos os tubos para realizar a confirmação das coletas no Sistema MV Soul:

- Acessar o sistema MV Soul com Login e Senha;
- Clicar na opção DIAGNÓSTICO E TERAPIA (ícone com desenho de microscópio), depois em COLETA, e na sequência em CONFIRMAÇÃO DE COLETA NOS SETORES E POSTOS;
- O campo AMOSTRA estará habilitado, e neste momento a confirmação das coletas poderá ser realizada através da leitura do código de barras dos tubos (se houver leitor disponível), ou digitando-se o número da amostra e depois Enter, no caso de não ter leitor de código de barras;
- Para cada amostra confirmada o sistema exibe uma mensagem com a informação de confirmação;

4.4.2 Imprimir novas etiquetas para os tubos e colar as etiquetas de identificação das amostras com o código de barras na posição VERTICAL sobre a etiqueta prévia de forma a permitir a visualização do nome do paciente na primeira etiqueta;

4.4.3 Por fim, separar as amostras já recebidas no sistema MV Soul e centrifugar as que necessitam desse procedimento, e posteriormente organizá-las para envio ao LMJ.

5. Siglas

5.1 PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;

5.2 LMJ – Laboratório Municipal de Joinville;

6. Controles e Eventos

6.1 Os principais controles do processo de coleta de sangue venoso são:

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

	Laboratório Municipal de Joinville	Código: IT COL-003
	Instrução de Trabalho	Versão: 1.0
	Coleta Domiciliar	Página: 7 de 7

6.1.3 A conferência do protocolo, documentação do paciente e etiquetas de identificação das amostras, feita pelo profissional de coleta;

6.1.2 A conferência do nome na etiqueta do tubo, feita pelo próprio paciente;

6.1.3 A confirmação da coleta no sistema MV Soul, evidenciando que a amostra foi de fato coletada.

7. Anexos

8. Observações Importantes

8.1 Nunca deixar o algodão embebido em álcool 70% em cima da agulha durante a coleta;

8.2 Respeitar a sequência correta de coleta dos tubos e seus VOLUMES e proceder a inversão em TODOS os tubos. Os tubos de EDTA e Fluoreto devem ser invertidos de 8 a 10 vezes. Já os tubos de Soro com gel separador e Citrato devem sofrer de 5 a 6 inversões. Atenção: Inverter os tubos gentilmente imediatamente após a coleta da amostra para que o sangue se misture com o aditivo apropriadamente. O movimento de virar o tubo para baixo e retorná-lo para a posição inicial corresponde a uma inversão completa. Não agitar os tubos fortemente. A agitação vigorosa pode causar hemólise na amostra;

8.3 É vedada a punção arterial, pois é procedimento privativo do enfermeiro;

8.4 Importante ressaltar a necessidade de treinamento e capacitação do coletador da coleta domiciliar pelo LMJ para que ele tenha acesso ao sistema MV Soul, onde o coletador realizará a confirmação de coleta dessas amostras e fazer a coleta com eficiência e segurança para realização dos exames.

9. Referências Bibliográficas

Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial para Coleta de sangue Venoso através do link - https://controllab.com/wp-content/uploads/guia_coleta_sangue.pdf

10. Controle de Versões

Elaboração	Revisão	Aprovação
Nome: Larissa Delmonego	Nome: Michelle R. A. Cordeiro	Nome: Carolina S. S. de Oliveira
Cargo: Analista Clínica	Cargo: Técnico em Análises Clínicas	Cargo: Coordenadora
Data: 19/05/2025	Data: 20/05/2025	Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura: